

Behandelplan Basis en Gespecialiseerde ggz Jeugd

Mevrouw X.L. van Ockenburg

Geboortedatum: 27 augustus 2012

BSN: 468557568

maandag 6 juli 2026

Reden aanmelding:

Xanne-Lynn is verwezen door de huisarts in verband met stemmingsklachten.

Huidige situatie:

Gezin: Xanne-Lynn groeit met haar twee oudere zussen op bij haar ouders. Ouders hebben ook een gezinshuis, waardoor er wisselend jong volwassenen bij hen inwonen.

School: Gsg Guido, 2 havo/vwo

Sociaal: Voldoende vriendinnen en een vriendje. Xanne-Lynn heeft wel verschillende keren de ervaring gehad dat vriendschappen abrupt eindigden, wat heeft bijgedragen aan onzekerheid.

Vrije tijd: Xanne-Lynn houdt van zingen en zit bij een jeugdvereniging van de kerk. Ze heeft gevolleybald, maar kan dit sinds een jaar niet meer doen wegens een knieblessure.

Beeld na de intakefase

De klachten van Xanne-Lynn lijken te zijn ontstaan vanuit een samenspel van aanleg en ingrijpende ervaringen gedurende haar ontwikkeling. Xanne-Lynn is van jongs af aan een sensitief meisje met een grote behoefte aan nabijheid, veiligheid en bevestiging. In de basisschoolperiode vielen meerdere belastende gebeurtenissen samen, waaronder een verhuizing, de verminderde beschikbaarheid van moeder door haar opleiding en later het gezinshuis, waardoor Xanne-Lynn zich minder gezien en gehoord voelde. Voor ouders was het, door een combinatie van drukte en eigen manieren om met emoties om te gaan, ook niet altijd gemakkelijk om sensitief op de emoties van Xanne-Lynn te reageren. Ze ontwikkelde al vroeg een sterke zelfkritische houding en de overtuiging dat gevoeligheid een zwakte is. Hierdoor leerde Xanne-Lynn haar gevoelens voor zichzelf te houden en problemen zelfstandig op te lossen, uit angst anderen te belasten of afgewezen te worden.

Deze kwetsbaarheid werd versterkt door verschillende ervaringen van pesten, buitensluiting en het verlies van belangrijke vriendschappen. Hierdoor ontwikkelde Xanne-Lynn negatieve overtuigingen over zichzelf, zoals dat zij niet belangrijk is, uiteindelijk verlaten wordt en er niet echt bij hoort. Vanuit deze overtuigingen en uit angst voor afwijzing probeert zij emoties en behoeften zoveel mogelijk te onderdrukken. Hoewel dit haar op korte termijn controle geeft, leidt het op langere termijn tot toenemende somberheid, piekeren, spanning, panieklachten en gevoelens van leegte. Automutilatie en suïcidale gedachten lijken vooral pogingen om met deze overweldigende emoties om te gaan en eraan te ontsnappen.

Beschermende factoren zijn het goede reflectievermogen van Xanne-Lynn, haar motivatie voor behandeling, de steun die zij ervaart vanuit haar geloof en de betrokkenheid van haar ouders, die bereid zijn hun eigen aandeel in de gezinsdynamiek te onderzoeken.

Bekeken aan de hand van de 6 pijlers van de positieve psychologie kan het volgende gesteld worden:

1. **Lichaamsfuncties.** Xanne-Lynn ervaart regelmatig lichamelijke spanningsklachten, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn en paniekaanvallen. Daarnaast heeft ze zichzelf verwond bij oplopende spanning. Haar slaap is wisselend; ze valt laat in slaap, maar slaapt daarna meestal door.
2. **Mentaal welbevinden.** Xanne-Lynn voelt zich al langere tijd somber, onzeker en eenzaam. Ze piekert veel, is erg zelfkritisch en ervaart gevoelens van leegte, angst en spanning. Ze denkt geregeld aan de dood, zonder concrete plannen, en heeft moeite om emoties te uiten of te verdragen.
3. **Zingeving.** Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van Xanne-Lynn en geeft haar houvast, verbondenheid en het gevoel geliefd te zijn. Tegelijkertijd is haar vertrouwen in de toekomst verminderd door de langdurige psychische klachten en terugkerende ervaringen van afwijzing.
4. **Kwaliteit van leven.** Xanne-Lynn beleeft plezier aan zingen, haar geloofsgemeenschap, contact met vrienden en haar

vriend. Door haar somberheid, piekeren en angst kan ze hier echter niet altijd van genieten en ervaart ze regelmatig weinig hoop en levensvreugde.

5. **Meedoen.** Op school functioneert Xanne-Lynn goed en heeft ze momenteel enkele vrienden en een vriendin. Eerdere ervaringen met pesten, buitensluiting en het verlies van vriendschappen maken dat ze zich vaak onzeker voelt in contacten en bang is opnieuw afgewezen te worden. Hierdoor voelt ze zich regelmatig alleen, ook binnen haar eigen gezin.
6. **Dagelijks leven.** Xanne-Lynn functioneert cognitief goed en gaat naar school, maar haar psychische klachten kosten haar veel energie en beïnvloeden haar dagelijks functioneren. Ze heeft de neiging problemen alleen op te lossen en vraagt moeilijk om steun, waardoor de belasting in het dagelijks leven toeneemt.

Behandelfocus

De behandeling richt zich op het versterken van de emotionele afstemming tussen Xanne-Lynn en haar ouders. Centraal staat het creëren van een veilige gezinscontext waarin Xanne-Lynn haar gevoelens geleidelijk leert herkennen, toelaten en delen, zonder deze te hoeven wegstoppen of vermijden. Ouders worden actief betrokken en leren sensitief en validerend aan te sluiten bij de emoties van Xanne-Lynn, zodat zij ervaart dat moeilijke gevoelens er mogen zijn en samen gedragen kunnen worden. Door meer openheid en emotionele veiligheid binnen de ouder-kindrelatie wordt verwacht dat Xanne-Lynn minder zelfkritisch wordt, minder spanning hoeft vast te houden en beter leert omgaan met verdriet, angst en onzekerheid.

Doelen

- Xanne-Lynn en haar ouders ontwikkelen meer openheid in het delen van gevoelens en behoeften, waardoor Xanne-Lynn ervaart dat haar emoties er mogen zijn en zij zich thuis meer gezien, gehoord en gesteund voelt.
- Ouders vergroten hun vermogen om de emoties en behoeften van Xanne-Lynn te herkennen, hier sensitief op aan te sluiten en emoties te valideren, zodat zij haar kunnen ondersteunen zonder gevoelens over te nemen of direct op te lossen.
- Xanne-Lynn leert haar gevoelens beter herkennen, benoemen en stap voor stap toe te laten, zodat zij minder afhankelijk wordt van het wegdrukken of vermijden van emoties en meer vertrouwen ontwikkelt in het omgaan met moeilijke gevoelens.
- Xanne-Lynn ontwikkelt meer begrip en acceptatie voor haar eigen sensitiviteit en leert met meer mildheid naar zichzelf te kijken, waardoor zelfkritiek en gevoelens van afwijzing geleidelijk afnemen.

Interventies

Systeemgesprekken en individuele behandeling.

Evaluatiemomenten

Na drie maanden wordt een evaluatiemoment gepland. Tijdens deze evaluatie wordt besproken hoe de behandeling verloopt, welke doelen behaald zijn en hoe Xanne-Lynn en haar ouders de behandeling ervaren. Na deze evaluatie wordt er gezamenlijk besloten of behandeling gecontinueerd wordt en zo ja in welke vorm en intensiteit.

Xanne-Lynn en haar ouders gaan akkoord met het behandelplan en geven toestemming om dit verslag naar de huisarts te verzenden:

O ja

O nee

Eventuele reactie:

Door dit document digitaal te ondertekenen of aan te vinken in het cliëntportaal, verklaart u zich akkoord.

Bureau Focus en Samenwerkende praktijken | Hortensialaan 1a, 6851 TB Huissen

Aangesloten praktijken: Bureau Focus (info@bureaufocus.nl, AGB: 94069262) Praktijk Bodem (nanon@praktijkbodem.nl, AGB: 94100562), AL psychologie (anke@alpsychologie.nl, AGB: 94068479), Leviva Psychologie (julia@levivapsychologie.nl, AGB: 94068496), Psychologiepraktijk MOED (jolein@psychologiepraktijkmoed.nl, AGB: 94066121) en De Opgroeiwinkel (jdeheus@opgroeiwinkel.nl, AGB: 94057642).

